

Datos Personales							
Nombre:	SALOME QUINTERO PEREZ	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2013-12-22	Edad	11 Años, 5 Meses, Y 6 Días
Identificación:	TI - 1137874112	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	ELOY.QUINTERO@HOTMAIL.COM - 1137874112			Dirección:	CALLE 16 BIS 25A-08 VILLA CORELCA		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		DALIDA ISABEL PEREZ ROMERO - Parentesco (madre) - Teléfono (3013060999)					

Apertura psicología del 2025-05-27 20:29:14: 11 años, 5 meses, y 6 días

DATOS GENERALES

Remisión

Particular

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere la madre, "Estoy preocupada porque Salo esta comiendo pared" "nos mudamos a una casa nueva y empezamos a ver las paredes dañadas otra vez hasta que dijo la verdad que comi pared hacia varios meses", "me toca estar detras de ella para que haga las tareas del colegio y las trae incompletas".

Enfermedad Actual

Paciente que presenta sintomatología caracterizada por la presencia de una conducta persistente de ingesta de sustancias no nutritivas, específicamente fragmentos de pared, con una duración de varios meses, sin aparente relación con déficits nutricionales conocidos hasta el momento. Esta conducta es descrita como reiterativa, de difícil control y de aparición en el entorno domiciliario, lo que sugiere una alteración en el patrón de comportamiento alimentario.

Adicionalmente, se evidencian dificultades en el ámbito académico, particularmente baja tolerancia hacia actividades de escritura, marcada desmotivación escolar y distractibilidad frecuente en el aula, manifestada por una constante búsqueda de interacción con pares durante el desarrollo de las clases. Estos elementos clínicos podrían estar relacionados con alteraciones en los procesos atencionales, funciones ejecutivas o aspectos emocionales no resueltos.

El cuadro clínico descrito es compatible con sintomatología que requiere evaluación diagnóstica diferencial, considerando posibles trastornos del neurodesarrollo, del comportamiento o de la regulación sensorial.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico Resección Del Tabiqué Baginal	Tóxicos No Refiere
Traumáticos Ninguno	Medicación Sulfato Ferroso Y Multivitaminicos.
Paraclínicos Ecografías	Hospitalizaciones Si
Patología Anemia	

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo 27 Años	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo Primero	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo No	Estado De La Madre Durante El Embarazo Se Documenta Historia De Inestabilidad Emocional Con Predominio De Irritabilidad Y Tristeza Durante El Embarazo

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Cesárea Electiva Debido A Temor Materno Al Parto Vaginal
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 3210
Talla Al Nacer 50	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere	Desarrollo Psicomotor Normal
--	--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2 M	Rolado 3 M
Sedente Solo 6 M	Gateo 6M
Bípedo Sin Ayuda 9M	Marcha 13 M
Lenguaje Verbal 16 M	Lenguaje Verbal Fluido 2 AÑOS

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción Primo Materno	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos HIPERTENSIÓN	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente, la paciente cursa el grado sexto en el colegio Villa Corelca. Presenta un buen rendimiento académico; sin embargo, en durante el proceso educativo se ha observado desorganización escolar, llegando a clases con el material incompleto y sin registrar las tareas o actividades asignadas para el hogar.
Historia laboral No refiere
Historia familiar el núcleo familiar esta conformado por el papá el señor Eloy Quintero Orozco con 38 años, la mamá la señora Dalida Perez Romero con 39 años, y la hermana Sra Quintero Perez con 2 años. En el entorno familiar se reportan desacuerdos y discusiones en presencia de la menor, así como episodios de gritos por parte de los padres en algunas ocasiones. Refiere antecedentes de separaciones intermitentes entre los progenitores.
Historia social La paciente muestra habilidades adecuadas para la interacción social, estableciendo relaciones con facilidad. Participa en actividades lúdicas, comparte con sus pares y se expresa a través de conductas esperadas para su edad. Se adapta a diferentes contextos sociales y no se evidencian dificultades significativas en su capacidad de comunicación o juego

Historia socio-afectiva En el ámbito socioafectivo, la paciente presenta habilidades para la interacción social, mostrando facilidad para relacionarse, jugar y compartir con otros. Sin embargo, en el entorno familiar se observan factores que pueden influir en su bienestar emocional, como desacuerdos y discusiones entre los padres en su presencia, episodios de gritos y antecedentes de separaciones intermitentes. En el contexto escolar, aunque mantiene un buen rendimiento académico, sin embargo, ha presentado dificultades en la organización de sus tareas y actividades. Estos factores podrían estar incidiendo en su estabilidad emocional y desempeño general.
--

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica No refiere
Intervención neurológica No refiere
Intervención neuropsicológica No refiere

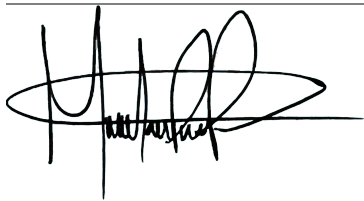
EXAMEN MENTAL
Examen Mental Paciente ingresa a consulta con adecuada disposición, saluda de forma espontánea y mantiene una actitud colaboradora durante la entrevista. Se encuentra alerta, orientada auto y alopsiquicamente, con presentación personal acorde al contexto. Muestra un contacto visual funcional, participación activa en la conversación y disposición para expresar sus opiniones. El lenguaje es coherente y adecuado para su edad, sin alteraciones en la estructura ni en el contenido. La atención se encuentra conservada durante la sesión y no se evidencian alteraciones del pensamiento. La inteligencia impresiona dentro del promedio, el juicio se mantiene conservado y la introspección es parcial. No se observaron indicadores de alteración del curso del pensamiento ni signos de ideación delirante o suicida.
Ciclos del Sueño Conservados.
Apetito Alterado.
Actividades de Autocuidado Independiente.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA
Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V): F983 - PICA EN LA INFANCIA Y LA NINEZ
Establecido por primera vez Si

PLAN DE INTERVENCIÓN
Plan de Intervención
Objetivo General Promover la regulación conductual y emocional de la paciente mediante una intervención psicológica integral que permita reducir la conducta de pica, mejorar la atención sostenida, aumentar la motivación escolar y fortalecer estrategias adaptativas de afrontamiento.
Objetivos Específicos • Identificar los factores desencadenantes y mantenedores de la conducta de ingesta no nutritiva (pica) mediante un análisis funcional basado en el Análisis de Conducta Aplicado (ABA). • Coordinar con otros profesionales de la salud (nutricionista, neuropediatra) para descartar deficiencias nutricionales o condiciones médicas subyacentes que puedan estar relacionadas con la conducta de pica. • Establecer estrategias de intervención conductual orientadas a la extinción progresiva de la conducta de comer pared, incorporando tecnicas de refuerzo diferencial, redirección, extinción, reforzadores positivos alternativos, extinción y mediadores sensoriales, para disminuir la frecuencia de la conducta de pica. • Proporcionar estimulación sensorial alternativa que sustituya la necesidad de masticar o ingerir materiales no comestibles, en caso de que la conducta tenga una función sensorial. • Fortalecer los procesos atencionales y de autorregulación mediante actividades estructuradas, orientadas al entrenamiento en funciones ejecutivas (atención sostenida, inhibición, planificación). • Abordar el rechazo hacia tareas académicas, especialmente de escritura, mediante técnicas de desensibilización, refuerzo positivo y acompañamiento motivacional. • Estimular el reconocimiento y expresión de emociones básicas mediante herramientas psicoeducativas y ejercicios de identificación emocional. • Trabajar en el fortalecimiento de la autoestima, autoconcepto y percepción de autoeficacia escolar y social. • Trabajar con la familia en la mejora del ambiente emocional y patrones de crianza, promoviendo estrategias de disciplina positiva, comunicación efectiva y reducción del uso de gritos como método correctivo.

Sugerencias e Interconsultas • Interconsulta con Nutricionista • Interconsulta con Neuropediatría • Interconsulta con Neuropsicología
--

Observaciones y Recomendaciones • Iniciar tratamiento por Psicología Clínica (1 vez por semana, durante 2 meses). • Supervisión ambiental en el hogar para evitar el acceso a materiales no comestibles y reforzar conductas adaptativas. • Dar un trato digno y con respeto. • Validar las emociones e implementar el estilo de crianza democratico.
--

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' and 'I' followed by a horizontal line and a small flourish.

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542